OdonTeck
CONSULTING GROUP

GUÍA CLÍNICA · ORTODONCIA

Diagnóstico ortodóncico en consulta general

Qué preguntar, qué medir y cuándo referir: el recorrido completo de la primera consulta en una guía de bolsillo.

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

Cómo usar esta guía

Está pensada para el odontólogo general que recibe a un paciente con una duda ortodóncica. Sigue el orden de la consulta: anamnesis, examen extraoral, examen intraoral, radiografías y decisión. Al final hay un formato de nota para dejar todo registrado.

> **Regla de oro**
> El diagnóstico ortodóncico no es solo dental: siempre evalúa también la cara, la función y la etapa de crecimiento. Un mismo apiñamiento se maneja distinto a los 8 que a los 30 años.

1 · Anamnesis dirigida

- **Motivo de consulta** en palabras del paciente (o del tutor): estética, función, dolor, referencia de otro colega.
- **Edad y etapa de crecimiento**: dentición temporal, mixta o permanente; en adolescentes, estirón puberal (cambios de talla recientes, menarca).
- **Hábitos**: succión digital o de chupón, respiración oral, deglución atípica, interposición lingual o labial, onicofagia, bruxismo.
- **Antecedentes familiares**: prognatismo o clase III en padres o hermanos, agenesias, caninos retenidos.
- **Traumatismos** dentales o faciales, fracturas mandibulares y tratamientos ortodóncicos previos.
- **Salud general**: medicamentos (bisfosfonatos), enfermedades periodontales, alergias (níquel, látex).

2 · Examen extraoral

Qué observar	Cómo	Qué anotar
Perfil	De lado, cabeza en posición natural	Recto, convexo o cóncavo; posición de labios respecto a la línea E
Simetría	De frente, línea media facial	Desviación del mentón, asimetrías de tercios
Tercios faciales	Glabela, subnasal, mentón	Tercio inferior aumentado (tendencia a mordida abierta) o disminuido
Competencia labial	Labios en reposo	Cierre sin esfuerzo o con contracción del mentón
Sonrisa	Sonrisa amplia espontánea	Exposición gingival, línea media dental vs facial, corredores bucales
ATM y apertura	Palpación, apertura máxima	Ruidos, dolor, desviación; apertura menor de 40 mm merece valoración

3 · Examen intraoral

Parámetro	Referencia habitual	Hallazgo que importa
Relación molar (Angle)	Clase I	Clase II o III, uni o bilateral
Relación canina	Clase I	Discrepancia con la relación molar (compensaciones)

Parámetro	Referencia habitual	Hallazgo que importa
Overjet (resalte)	2–3 mm	Aumentado (≥6 mm eleva el riesgo de trauma) o negativo
Overbite (sobremordida)	2–3 mm	Profunda con impacto en paladar, o mordida abierta
Mordida cruzada	Ausente	Anterior o posterior; con desplazamiento funcional mandibular
Líneas medias	Coincidentes	Desviación mayor de 2 mm: ¿dental o esquelética?
Espacio	Sin apiñamiento	Apiñamiento o diastemas; estima los milímetros por arcada
Dentición	Acorde a la edad	Agenesias, supernumerarios, retenciones, anquilosis de temporales

Clasificación de Angle en un vistazo

Clase	Relación molar	Rasgos frecuentes
I	Cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior	Maloclusión dental: apiñamiento, rotaciones, diastemas
II división 1	Molar inferior en posición distal	Incisivos superiores proinclinados, overjet aumentado, perfil convexo
II división 2	Molar inferior en posición distal	Centrales superiores retroinclinados, laterales vestibularizados, sobremordida profunda
III	Molar inferior en posición mesial	Overjet reducido o negativo, mordida cruzada anterior, perfil cóncavo

4 · Radiografía panorámica: checklist

- [ ] Conteo dental y fórmula completa: agenesias (frecuentes en laterales superiores y segundos premolares) y supernumerarios.
- [ ] Secuencia y estadio de erupción; simetría derecha–izquierda.
- [ ] Posición de caninos superiores: inclinación y relación con la raíz del lateral.
- [ ] Reabsorciones radiculares en temporales y permanentes vecinos a dientes retenidos.
- [ ] Terceros molares: presencia, posición y espacio disponible.
- [ ] Cóndilos y ramas: forma y simetría.
- [ ] Nivel óseo, lesiones periapicales, quistes o imágenes que no correspondan.

5 · Cefalometría básica (si se cuenta con lateral de cráneo)

Medida (Steiner)	Norma	Lectura rápida
SNA	82° ± 2°	Posición anteroposterior del maxilar
SNB	80° ± 2°	Posición anteroposterior de la mandíbula
ANB	2° ± 2°	Mayor de 4°: tendencia clase II esquelética · menor de 0°: tendencia clase III
SN–GoGn	32° ± 5°	Alto: patrón vertical (abierto) · bajo: patrón horizontal (profundo)

Las normas son promedios poblacionales: interprétalas junto con el perfil blando y la edad.

6 · Semáforo de referencia

	Situación	Acción
Referir pronto	Mordida cruzada anterior o posterior en crecimiento, sobre todo con desplazamiento funcional · Clase III esquelética en niños · Canino superior no palpable en vestibular a los 10–11 años o asimetría marcada de erupción · Mordida abierta con hábito persistente · Overjet de 6 mm o más	Interconsulta con ortodoncia en semanas, no meses
Valorar y vigilar	Apiñamiento moderado en dentición mixta · Diastemas en dentición mixta temprana · Pérdida prematura de temporales (mantenedor de espacio)	Control cada 6 meses con registro fotográfico
Seguimiento de rutina	Maloclusión leve en adulto sin demanda estética ni función alterada	Informar opciones y registrar en el expediente

Canino superior retenido
La palpación de la eminencia canina en vestibular desde los 10 años y la panorámica temprana permiten intervenir a tiempo (por ejemplo, extracción del canino temporal por indicación del ortodoncista). Llegar tarde suele significar cirugía y tracción.

7 · Formato de nota de primera consulta

Paciente _____ Edad _____ Dentición _____

Motivo de consulta

Perfil | Relación molar D / I | Relación canina D / I

Overjet (mm) | Overbite (mm) | Mordidas cruzadas | Líneas medias

Hallazgos radiográficos

Impresión diagnóstica y plan (referir / vigilar / tratar)

Referencias

1. Proffit WR, Fields HW, Larson BE, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. 6.ª ed. Elsevier; 2019.
2. Steiner CC. Cephalometrics for you and me. Am J Orthod. 1953;39(10):729–755.
3. American Association of Orthodontists. Clinical Practice Guidelines for Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
4. Ericson S, Kurol J. Early treatment of palatally erupting maxillary canines by extraction of the primary canines. Eur J Orthod. 1988;10(4):283–295.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.